# Auditoría de historia

## Finalidad y momento de uso

Registrar auditoría de historia en el momento de la actividad correspondiente a ODO-HC01. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

## Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

## Historia codificada / fecha / revisor

Identificar de manera inequívoca el objeto o usuario del registro. En controles administrativos usar código y ubicación reservada del soporte; verificar identidad antes de decisiones clínicas o entrega.

## Identificación antecedentes examen odontograma

Diligenciar dato concreto y pertinente a auditoría de historia. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

## Diagnóstico plan alternativas / consentimiento

Registrar información particular, comprensión, voluntariedad y decisión, con apoyos o representación cuando corresponde. Vincular evidencia jurídicamente válida; no equivale a aceptación un nombre digitado aislado.

## Evolución medicamentos trazabilidad

Diligenciar dato concreto y pertinente a auditoría de historia. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

## Autoría cronología / anexos

Identificar persona y rol que ejecuta o verifica, no solamente cargo genérico. Asociar autenticación válida cuando la naturaleza del registro la exige y proteger permisos de acceso.

## Custodia acceso respaldo / hallazgo

Describir resultado real, desviación y medida concreta; asignar plazo y quién verificará eficacia. No cerrar únicamente porque se redactó un plan o se pidió una reparación.

# Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-HC01 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

| Campo | Registro |
|---|---|
| Historia codificada / fecha / revisor | |
| Identificación antecedentes examen odontograma | |
| Diagnóstico plan alternativas / consentimiento | |
| Evolución medicamentos trazabilidad | |
| Autoría cronología / anexos | |
| Custodia acceso respaldo / hallazgo | |
| Acción / plazo / verificación | |

## Observaciones y soporte vinculado

# Criterios de revisión y custodia del registro

## Condiciones de entrada

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

## Decisión y preparación

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

## Registro de ejecución

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

## Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

## Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

## Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

## Historia clínica y reserva

Resolución 1995 de 1999, artículos 3 a 5 y 11 a 14; Resolución 839 de 2017, conservación y reglas especiales. El diseño sin casillas de firma exige asociar autoría y aceptación válidas antes del uso clínico.

https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx